Vaccinations et Sclérose en plaques

Recommandations du Groupe Français Vaccinations et SEP sous l'égide de la SFSEP

Recommandation endossée par la SPILF

Diaporama réalisé par le groupe recommandations de la SPILF

Synthèse réalisée le 13/11/2019 par la SPILF

SEP et immunodépression: définitions

- La SEP ne provoque pas d'immunodépression
- Les traitements immunomodulateurs (interferon et acétate de glatiramer) n'entrainent pas d'immunodépression
- Le tériflunomide (action sur la prolifération lymphocytaire) et le dimethylfumarate (lymphopénie) doivent faire considérer une potentielle immunosuppression
- Fingolimod, natalizumab, mitoxantrone, ocrelizumab, azathioprine, cellcept, alemtuzumab, cladribine, rituximab, cyclophosphamide sont à considérer comme immunosuppresseurs.

Synthèse réalisée le 13/11/2019 par la SPILF

SEP et vaccins: pas de risque démontré

- Pas de risque accru de survenue d'une SEP ou d'un premier épisode démyélinisant du système nerveux central, **y compris après vaccination contre l'hépatite B et les papillomavirus humains** (grade B).

- Pas de risque accru de survenue d'une poussée chez un patient ayant une SEP après vaccination (grade B).

- Pas d'impact sur l'évolution du handicap à court terme associé au vaccin contre la grippe et au BCG (grade C). L'effet des autres vaccins sur le handicap n'a pas été étudié.

- Un risque accru de poussée après vaccination contre la fièvre jaune ne peut pas être exclu (grade C).

Synthèse réalisée le 13/11/2019 par la SPILF

Données d’efficacité vaccinale
Patients sans traitement immunoactif

- Vaccins inactivés: efficacité similaire à la population générale, notamment pour les vaccins mono- et trivalent contre la grippe (grade C).

- Vaccins vivants atténués: aucune étude n’est disponible

Données d'efficacité vaccinale
Patients avec traitement immunoactif

Traitements immunoactifs	Vaccins étudiés	Réponse au vaccin chez les patients atteints de SEP
Interférons bêta	Grippe, méningocoque, pneumocoque, DT	Pas de diminution
Acétate de glatiramer	Grippe	Pas de diminution
Diméthylfumarate	Méningocoque, pneumocoque, DT	Similaire vs patients traités par interféron
Tériflunomide	Grippe	Diminuée vs patients traités par interféron
Mitoxantrone	Grippe	Insuffisante
Natalizumab	Grippe Tétanos	Diminuée Pas de diminution
Fingolimod	Tous	Diminuée
Ocrelizumab	Tétanos, pneumocoque, grippe	Diminuée à 12 semaines vs patients traités par interféron
Alemtuzumab, Cladribine, Cyclophosphamide, Méthotrexate, Azathioprine/mycophénolate mofétil, Rituximab et anti-CD20	Aucun	Pas de données

Synthèse réalisée le 15/11/2018 par la SPILF

SEP non traitée : vérifier le statut vaccinal

- **Consulter** le carnet de vaccination avec attention particulière pour ROR, VHB, VZV, hépatite A

- **Vérifier les sérologies (Ig G)** pour

✓ Rougeole et rubéole si date de naissance < 1980 sans ATCD de maladie ou pas d'information.

✓ Hépatite B (sérologie complète)

✓ VZV

✓ Hépatite A chez des personnes ayant eu un antécédent d'ictère ou ayant séjourné ou habité en zone d'endémie.

SEP non traitée ou traitée par interférons béta ou acétate de glatiramer

Mettre à jour l'immunisation vaccinale (1):

- dTP ou dTCaP selon l'âge
- ROR : rattrapage pour atteindre 2 doses pour les patients nés après 1980 (4 semaines au moins avant traitement immunomodulateur)

• Coqueluche (si cocooning 1 dose de dTCaP, si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 5 ans)

• Hépatite B

• VZV en cas de sérologie négative : 2 doses (dernière dose 4 semaines au moins avant traitement immunomodulateur)

Synthèse réalisée le 13/11/2019 par la SPILF

SEP non traitée ou traitée par interférons béta ou acétate de glatiramer

Mettre à jour l'immunisation vaccinale (2):

- Pneumocoque si facteurs de risque
- Méningocoque si facteurs de risque
- Vaccination antigrippale annuelle
- Hépatite A chez les personnes à risque

SEP non traitée ou traitée par interférons béta ou acétate de glatiramer

Situations particulières:

• La vaccination anti grippale est recommandée chez les patients non traités avec handicap *(EDSS≥3.0)* et conseillée chez les autres

• Les bolus de corticoïdes contre-indiquent un vaccin vivant durant les trois mois qui suivent

SEP non traitée ou traitée par interférons béta ou acétate de glatiramer

En cas de traitement immunosuppresseur programmé:

- Vaccin varicelle si sérologie négative 2 doses (dernière dose 4 semaines au moins avant traitement immunomodulateur)
- Vaccin anti-pneumococcique : Prévenar13 suivi de Pneumovax 2 mois plus tard
- Vaccin contre l'hépatite B si projet de traitement par anti-CD20

Synthèse réalisée le 13/11/2019 par la SPILF

Avant un traitement immunosuppresseur

Patient n'ayant jamais reçu d'immunosuppresseurs :

- dTP ou dTCaP (selon l'âge) tous les 10 ans à partir de 25 ans (schéma différent de la population générale)
- Vaccin varicelle si sérologie négative : 2 doses espacées de 4 à 8 semaines selon l'AMM du vaccin
- Rattrapage ROR chez les patients nés depuis 1980 pour atteindre 2 doses (vaccin vivant donc attendre 4 semaines pour débuter le traitement immunosuppresseur)
- Vaccination anti-pneumococcique : Prévenar13 suivi de Pneumovax 2 mois plus tard

Avant de débuter un traitement immunosuppresseur

SEP active avec début de traitement en urgence :

- dTP ou dTCaP
- Grippe saisonnière
- Prévenar13 suivi du vaccin polysaccharidique à 23 valences au moins 2 mois après (et au moins 6 semaines après la perfusion de traitement immunosuppresseur)
- ROR, varicelle et autres vaccins vivants sont contre-indiqués

Avant un nouveau traitement immunosuppresseur

Patient ayant déjà reçu des immunosuppresseurs :

- dTP ou dTCaP jusqu'à 39 ans, si rattrapage non fait à 25 ans
- Varicelle (2 doses espacées de 4 à 8 semaines selon l'AMM du vaccin)
- Pneumocoque selon le schéma adapté à l'âge du patient
- Grippe saisonnière

Traitement immunosuppresseur en cours

Dans tous les cas

- Prévenar13 : possible à tout moment mais de préférence à distance d'une cure (au moins 6 semaines)
- Grippe saisonnière
- Vaccins vivants contre-indiqués : délai 3 mois minimum après arrêt des immunosuppresseurs
- Vaccinations à jour fortement recommandées pour l'entourage: grippe, varicelle, ROR, coqueluche

SEP et vaccinations

Compléments pour l'argumentaire et les situations particulières

https://sfsep.org/sep-et-vaccinations/

Synthèse réalisée le 13/11/2019 par la SPILF